KIT 8 – SÍNDROME FEBRIL AGUDA SEM FOCO DEFINIDO

Referências: ABRAMEDE 2024 • Ministério da Saúde – Protocolos de Manejo de Febre Aguda 2023 • SBIM • ILAS • OMS

Objetivo

Padronizar a solicitação de exames laboratoriais e de imagem em pacientes com **síndrome febril aguda (SFA)** sem foco aparente na admissão, visando o **diagnóstico precoce de doenças infecciosas**, a **racionalização dos exames** e a **segurança clínica** do atendimento.

---

1. AVALIAÇÃO INICIAL – ABORDAGEM CLÍNICA

- Considerar **síndrome febril aguda** quando há **febre ≤ 7 dias** associada ou não a sintomas sistêmicos inespecíficos (cefaleia, mialgia, náusea, exantema, artralgia, dor retro-orbitária, prostração).
- Avaliar **sinais de gravidade**: hipotensão, taquicardia, confusão mental, dispneia, dor abdominal intensa, sangramento, icterícia ou oligúria.
- Investigar **histórico epidemiológico** (dengue, zika, chikungunya, leptospirose, COVID, malária, febre tifóide).
- Realizar **exame físico completo e minucioso**, com atenção a linfonodos, exantema, mucosas e ausculta pulmonar.

---

2. EXAMES LABORATORIAIS

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
Hemograma completo	Todos os pacientes com febre ≥ 48h; auxilia no diagnóstico diferencial (leucopenia viral, leucocitose bacteriana, plaquetopenia).	Febre leve < 24h em adultos previamente hígidos.
Função renal (ureia e creatinina)	Avaliar gravidade e hidratação, suspeita de leptospirose, sepse, dengue grave.	Casos leves sem sintomas sistêmicos.
Transaminases (TGO/TGP)	Suspeita de hepatite viral, dengue, febre tifóide, leptospirose.	Febre isolada sem icterícia nem dor abdominal.
Eletrólitos (Na, K)	Pacientes com vômitos, diarreia ou sinais de desidratação.	Casos leves.

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
PCR / Procalcitonina	Diferenciação entre origem viral e bacteriana; controle de resposta terapêutica.	Casos leves, sem sinais sistêmicos.
Gasometria + Lactato	Pacientes com hipotensão, taquipneia, confusão mental ou sepse.	Casos leves sem repercussão sistêmica.
EAS (Urina tipo I)	Pesquisa de ITU, pielonefrite, leptospirose (proteinúria, hematuria).	Febre isolada sem sintomas urinários.
Hemoculturas (2 amostras)	Pacientes com febre persistente (> 72h), sepse, calafrios ou imunossuprimidos.	Casos leves, febre autolimitada.
Sorologias rápidas	Conforme suspeita clínica e área endêmica:	

3. EXAMES DE IMAGEM

Exame	Indicação	Evitar / Não Indicado
RX de Tórax (PA/AP)	Febre com tosse, dispneia, crepitações, ou suspeita de pneumonia / COVID-19.	Febre isolada sem sintomas respiratórios.
USG abdominal total (POCUS)	Suspeita de dengue grave (ascite, derrame pleural, hepatoesplenomegalia), leptospirose, dor abdominal persistente.	Febre isolada sem dor abdominal.
USG de vias urinárias / rins	Suspeita de pielonefrite, ITU febril, dor lombar ou hematúria.	Casos sem queixa urinária.
TC de abdome / tórax	Apenas em casos com suspeita de complicações graves (abscesso, sepse, sangramento).	Casos leves sem critérios de gravidade.

4. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLÍNICO

Classificação	Critérios	Conduta e Exames
Baixo risco (SFA leve)	Febre < 3 dias, bom estado geral, sem sinais de gravidade.	Hemograma isolado; hidratação oral; observação.
Risco intermediário	Febre ≥ 3 dias, sintomas sistêmicos leves, sem instabilidade.	Hemograma, função renal, transaminases, EAS, sorologias básicas.
Alto risco (SFA grave / sepse)	Hipotensão, taquicardia, plaquetopenia, sangramento, icterícia, confusão mental.	Hemograma completo, função renal/hepática, lactato, PCR, culturas, imagem dirigida.

5. PRIORIDADES

- Avaliar e registrar **tempo de febre, área endêmica e comorbidades**.
- Realizar **hidratação precoce** em casos suspeitos de dengue, leptospirose e sepse.
- Solicitar **sorologias específicas** apenas quando houver **suspeita epidemiológica real**.
- **Evitar solicitações simultâneas** de múltiplas sorologias sem indicação clínica.
- Em casos de **febre persistente > 7 dias**, reavaliar diagnósticos não infecciosos (autoimunes, neoplásicos).

Resumo Prático:

Cenário Clínico	Exames Laboratoriais	Exames de Imagem
Febre leve ≤ 3 dias	Hemograma simples	Nenhum exame inicial
Febre persistente ≥ 3 dias	Hemograma, função renal e hepática, EAS, PCR	RX tórax ± USG abdome
Febre com tosse / dispneia	Hemograma, PCR, gasometria, Ureia	RX tórax ± TC
Febre com icterícia / dor abdominal	Função hepática, eletrólitos, bilirrubina	USG abdome total
Febre com hipotensão / sepse	Hemograma, lactato, culturas, função orgânica completa	USG POCUS ± TC dirigida

Conclusão

A investigação da **síndrome febril aguda sem foco definido** deve seguir critérios clínicos e epidemiológicos, evitando excesso de exames e priorizando a identificação de sinais de gravidade.

✅ Diagnóstico rápido e direcionado
✅ Solicitação racional de exames
✅ Redução de custos e sobrecarga laboratorial
✅ Melhoria do fluxo e segurança do paciente